

Propuesta RD — AP y vida independiente (plan trienal)

Propuesta de proyecto (BORRADOR) — Vida independiente y asistencia personal dirigida por la persona en el Sistema de Cuidados de la República Dominicana

Plan trienal 2027–2029 · rumbo a la XVII Conferencia Regional sobre la Mujer (CEPAL, Colombia, 2028) y a los ODS 2030

Documento de trabajo (borrador inicial — para discutir y afinar) · RELAVIN · julio de 2026

Nota: este es un primer esbozo de gran marco. Cifras, plazos e indicadores se ajustarán con las contrapartes (CONADIS, INFOTEP, Supérate, OIT, JICA, CIMUDIS/Cristina).

Destino de financiamiento buscado: este proyecto se diseña para captar **financiamiento internacional de la banca de desarrollo** (CAF, BID, Banco Mundial). Los fondos nacionales (FONADIS, Supérate) se plantean como **contrapartida y vía de sostenibilidad**, no como fuente principal.

1. Justificación — por qué la República Dominicana y por qué ahora

- **RD es el primer país de la región en construir un sistema integral de cuidados** (Mesa Intersectorial 2022; piloto *Comunidades de Cuidado*; ley del Sistema Nacional de Cuidados en primera lectura, abril 2026). Puede ser el **buen ejemplo regional** de inclusión de las personas con discapacidad.
- **La vía ya está pavimentada:** existe el estándar de competencia y los 4 módulos de “Asistencia Personal a PcD” (INFOTEP/OIT/MEPyD, 2023) y 29 formadores certificados (2024). Pero **la rama de discapacidad se detuvo:** la formación masiva y el servicio avanzaron para el cuidado de personas mayores, no para la asistencia personal a personas con discapacidad.
- **2026 es la ventana:** el propio gobierno anunció activar en 2026 la modalidad “Asistente Personal para Personas con Discapacidad” (Supérate/CONADIS).
- **Lo que faltó en 2023 es justo lo que RELAVIN aporta:** la filosofía de vida independiente y la **conducción del servicio por la propia persona** (criterio central del Comité CDPD y de la Herramienta OHCHR), con personas con discapacidad como docentes y proveedoras.
- **Respaldo de derechos:** las recomendaciones del Comité CDPD a RD (2015, CRPD/C/DOM/CO/1) sobre capacidad jurídica (art. 12) y vida independiente /

desinstitucionalización (art. 19) llevan ~11 años pendientes. Este proyecto es una vía concreta para ejecutarlas.

2. Objetivo general

Consolidar en la República Dominicana un modelo de **asistencia personal dirigida por la persona** e integrado al sistema nacional de cuidados, conducido por las propias personas con discapacidad, que sirva de **buena práctica regional** a presentar en la XVII Conferencia (CEPAL, Colombia 2028) y que contribuya a los **ODS 2030**.

3. Objetivos específicos

1. **Constituir un Centro de Vida Independiente (CVI) piloto** liderado por mujeres con discapacidad (CIMUDIS) como entidad **proveedora/despachadora** de asistentes personales.
2. **Completar el diseño formativo** (revisión de los 4 módulos INFOTEP) incorporando la conducción por la persona y la filosofía de vida independiente.
3. **Lograr que la prestación piloto 2026+ de AP incluya la dirección del servicio por la persona**, articulando CONADIS, FONADIS, Supérate y SIUBEN.
4. **Formar asistentes personales con personas con discapacidad como docentes** (el modelo que ya usa el programa de cuidadoras).
5. **Evaluar con la Herramienta OHCHR** y documentar la experiencia para CEPAL 2028 y el reporte ODS.

4. Alineación estratégica

- **Estrategia RELAVIN (doble articulación):** desde el movimiento de base (CIMUDIS) hacia los organismos internacionales (OIT, ONU) y desde estos hacia la política nacional (CONADIS, Ley SNC).
- **CEPAL / Colombia 2028:** RD como caso a mostrar en la XVII Conferencia, en línea con la serie de webinars del Comité de Seguimiento del Compromiso de Tlatelolco (economía del cuidado x discapacidad).
- **ODS 2030:** el piloto se financia con Fondo ODS; el proyecto contribuye directamente a **ODS 3** (salud y bienestar), **ODS 5** (género — CVI liderado por mujeres), **ODS 8** (trabajo decente — AP como empleo digno, Convenios OIT 159/189), **ODS 10** (reducción de desigualdades) y **ODS 11** (comunidades inclusivas).
- **Marco normativo internacional:** CDPD art. 12 y 19; Herramienta de Evaluación OHCHR (indicador 1.2.3 — CVIs y cooperativas de AP en la red de prestación).

5. Componentes

1. **Formación y currículo** — revisión ligera de módulos (conducción por la persona) + cohorte piloto de AP con PcD como docentes. Contraparte: INFOTEP (Departamento Curricular).

2. **CVI proveedor** — constitución de un CVI/cooperativa de AP liderado por mujeres con discapacidad; entrada por “Mipymes Mujer” y variante de economía social y solidaria (respaldo OIT *Cuidando desde el territorio*, 2025).
3. **Articulación de política y prestación** — mesa con CONADIS/FONADIS/Supérate para que la modalidad de AP arranque con dirección por la persona; incidencia en el reglamento de FONADIS y en la Ley del SNC.
4. **Cooperación sur-sur y regional** — intercambio con Perú (DS 001) y con Costa Rica (Morpho); preparación de la réplica (Panamá).
5. **Evidencia e incidencia internacional** — línea base y evaluación con la Herramienta OHCHR; producto de comunicación para CEPAL 2028 y aporte al seguimiento de ODS.

6. Plan trienal (hitos por año)

Fase preparatoria — 2026 (en curso)

- Diálogo ya abierto con INFOTEP (kickoff 17-jul-2026), OIT y las contrapartes; mapeo institucional; incorporación del liderazgo con formación en vida independiente (JICA). Es la base sobre la que arranca el Año 1.

Año 1 — Fundación y diseño (2027)

- Revisión curricular con enfoque de conducción por la persona (INFOTEP).
- Constitución del CVI piloto (CIMUDIS); definición de la figura de proveedor de AP.
- Mesa de articulación CONADIS / FONADIS / Supérate / SIUBEN.
- Línea base con la Herramienta OHCHR. Puente inicial con Perú. Coordinación con el proyecto JICA 2027–2029 (CONADIS).

Año 2 — Implementación piloto (2028)

- Cohorte de formación de AP con personas con discapacidad como docentes.
- Arranque del servicio de AP **dirigido por la persona** en 1–2 territorios de Comunidades de Cuidado.
- CVI operando como entidad proveedora (MIPYMES Mujer / ESS).
- **HITO 2028:** presentar RD como buena práctica en la XVII Conferencia Regional (CEPAL, Colombia), articulado con los webinars del Comité.

Año 3 — Consolidación y escalamiento (2029)

- Institucionalización: reglamento de FONADIS; requisitos del proveedor con prioridad a entidades dirigidas por PcD; inclusión explícita en la Ley del SNC.
- Evaluación de resultados con la Herramienta OHCHR (avance vs. línea base).
- Réplica a nuevos territorios y puente regional (Panamá). **Horizonte ODS 2030.**

7. Actores y roles

- **Movimiento / ejecución técnica:** CIMUDIS, RELAVIN.

- **Rectoría y financiamiento estatal:** CONADIS + FONADIS; Supérate; MEPyD (Mesa de Cuidados); SIUBEN.
- **Formación:** INFOTEP (Departamento Curricular); ADR / Academia Habilita como red de entrega, aliada.
- **Cooperación internacional:** OIT (oficina RD y nivel regional); JICA (proyecto 2027–2029 con CONADIS); PNUD/UNICEF/UNFPA/ONU Mujeres (GDF / Fondo ODS).

8. Financiamiento — banca multilateral de desarrollo (eje del proyecto)

Fuente principal buscada — banca de desarrollo:

- **CAF — Banco de Desarrollo de América Latina.**
- **BID — Banco Interamericano de Desarrollo** (agenda de economía del cuidado y protección social).
- **Banco Mundial** (sistemas de protección social / SIUBEN; inclusión de la discapacidad; capital humano).

Instrumento probable: cooperación técnica no reembolsable / donación para la fase de diseño y piloto (Años 1–2) y, eventualmente, un componente de préstamo de inversión con contraparte soberana para el escalamiento (Año 3+).

Requisito clave — contraparte pública: la banca de desarrollo opera con una institución del Estado como contraparte. → **Vehículo: CONADIS** (rectoría nacional de discapacidad) como **contraparte oficial**, y **RELAVIN / CIMUDIS como socio técnico ejecutor**.

Contrapartida y sostenibilidad nacional: FONADIS (fondo designado a vida independiente), **Supérate / Comunidades de Cuidado** (Fondo ODS) y el mecanismo de **licitación / MIPYMES** — como aporte nacional y como vía de continuidad tras el cierre del proyecto (traspaso a presupuesto nacional).

Cooperación complementaria: JICA (2027–2029), OIT, agencias ONU (GDF).

Presupuesto: por estimar; escala indicativa de una cooperación técnica no reembolsable, a definir con la banca y la contraparte.

8-bis. Por qué es financiable (alineación con las prioridades de la banca)

- **Economía del cuidado y género** (BID, CAF): CVI liderado por mujeres con discapacidad; empleo digno; corresponsabilidad de los cuidados.
- **Protección social y focalización** (Banco Mundial): integración con SIUBEN y con el sistema nacional de cuidados en construcción.
- **Trabajo decente** (transversal, respaldo OIT): formalización del asistente personal (Convenios 159 y 189).
- **Inclusión de la discapacidad y CDPD** (art. 12 y 19): salvaguardas y estándares que la banca ya adopta; ejecución de recomendaciones pendientes del Comité CDPD.
- **ODS 2030:** marco de resultados directo (ODS 3, 5, 8, 10, 11).

- **Perfil catalítico + sostenible:** el financiamiento externo **activa la rama de discapacidad** que hoy está detenida y se apoya en un **sistema nacional ya existente**, con traspaso posterior al presupuesto nacional — exactamente el perfil que valora la banca de desarrollo.

8-ter. Referencia empírica del costo de asistencia personal

Como el costo permanente del servicio de AP lo asume el Estado (vía FONADIS / Sistema Nacional de Cuidados), no el proyecto, esta referencia sirve solo para **dimensionar la escala** — y muestra que es modesta y sostenible:

Proyecto Morpho (Costa Rica), 2013 — antes de la Ley 9379: el centro sostenía la vida independiente de **6 personas usuarias** con una **bolsa rotativa de ~10 asistentes personales** (equipos de hombres y mujeres, asignados según el género de la persona usuaria). En agosto de 2013 se prestaron **919 horas de asistencia** a **¢2.000/hora**, con un costo total de **¢1.838.000/mes (~US\$3.700): ¢405.000 (22%) aportados por el Estado (CNREE) y ¢1.433.000 (78%) por el proyecto** — es decir, ~150 horas y ~US\$600 por persona usuaria/mes.

Tras la ejecución de la Ley 9379 en 2019, el Estado asumió prácticamente el 100% y la carga del proyecto se redujo a cero.

Traslado a RD: con el salario mínimo local del trabajo de cuidado, un piloto de **6 personas usuarias (~900 h/mes)** se ubica en el orden de **US\$1.400–1.800/mes** de servicio de AP, escalable según el número de personas usuarias — un monto que el sistema nacional de cuidados puede absorber de forma sostenible.

9. Indicadores (borrador, a afinar)

- N.º de asistentes personales formados con enfoque de conducción por la persona; % con PcD como docentes.
- N.º de personas con discapacidad recibiendo AP dirigida por ellas mismas.
- CVI proveedor constituido y operando; contratos/licitaciones ganadas.
- Avance en la Herramienta OHCHR (indicadores de AP / dirección por la persona) vs. línea base.
- Cambios normativos: reglamento FONADIS; requisitos de proveedor; mención en la Ley del SNC.

10. Riesgos y mitigación

- **Medicalización / dilución del rol de AP** (perfil de ingreso de enfermería; salidas en centros residenciales) → revisión curricular + docentes con discapacidad.
- **Captura de las licitaciones por agencias genéricas de cuidado de mayores** → plantear temprano la prioridad del proveedor dirigido por PcD.
- **AP absorbida por la rehabilitación** → aprovechar a las personas formadas en VI dentro del Estado y de la red de rehabilitación (JICA) para “corregir desde adentro”.

- **Dependencia de voluntades individuales** → anclar en normas (reglamento, ley) y en la Herramienta OHCHR.

11. Próximos pasos

1. Validar el gran marco con las contrapartes clave.
2. Definir territorio(s) piloto y la contraparte financiera principal (FONADIS vs. Supérate).
3. Aterrizar el Año 1 en un plan de trabajo con responsables y fechas.

Borrador inicial de RELAVIN (julio 2026). Se irá afinando.